



SAVI Acarbose 100

Để xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

(Cho 1 viên nén bao phim SAVI ACARBOSE 100)

Thành phần dược chất:

Acarbose 100 mg

Thành phần tá dược:

Microcrystalline cellulose 102, pregelatinized starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose 6cps, hydroxypropyl methylcellulose 15cps, polyethylene glycol 6000, titan dioxide, talc.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nén dài, bao phim màu trắng, hai mặt khum, một mặt trơn, một mặt có vạch ngang, cạnh và thành viên lành lặn.

Lưu ý: Vạch ngang trên viên thuốc không nhằm mục đích bẻ đôi viên.

CHỈ ĐỊNH

SAVI ACARBOSE 100 được dùng như thuốc phụ trợ cho chế độ ăn và tập luyện để cải thiện việc kiểm soát đường huyết ở người lớn bệnh đái tháo đường type 2.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Không có liều cố định để điều trị đái tháo đường bằng acarbose hoặc bất kỳ thuốc nào khác. Liều dùng của acarbose tùy vào hiệu quả và dung nạp của từng bệnh nhân nhưng không vượt quá liều tối đa 100 mg/lần, 3 lần/ngày. Acarbose dùng 3 lần mỗi ngày (nên nhai cùng với miếng ăn đầu tiên hoặc uống nguyên viên thuốc với một ít nước ngay trước khi ăn) vào đầu mỗi bữa ăn chính. Nên bắt đầu dùng ở liều thấp và tăng dần liều để giảm tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa và có thể xác định liều tối thiểu cần thiết để kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không tuân theo chế độ ăn kiêng có thể làm tăng các tác dụng không mong muốn ở đường ruột. Nếu xuất hiện các cơn đau dữ dội mặc dù đã tuân theo chế độ ăn kiêng dành cho người đái tháo đường, bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ vì có thể phải giảm liều tạm thời hoặc cố định.

Trong quá trình điều trị ban đầu và điều chỉnh liều, phải đo nồng độ glucose huyết một giờ sau khi ăn để xác định đáp ứng điều trị với acarbose và liều tối thiểu có hiệu quả cho bệnh nhân. Sau đó, đo nồng độ hemoglobin glycosylate khoảng 3 tháng 1 lần. Mục tiêu điều trị là giảm lượng glucose huyết sau bữa ăn và đưa nồng độ hemoglobin glycosylate về mức bình thường hoặc gần bình thường bằng cách sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả, dùng acarbose đơn trị liệu hoặc phối hợp với sulfonylurea, insulin hoặc metformin.

Nếu quên uống một liều, phải đợi đến giờ ăn tiếp theo và uống liều kế tiếp. Không dùng lại liều đã quên. Không uống thuốc giữa các bữa ăn.

Liều ban đầu

Liều khởi đầu khuyến cáo là 25 mg/lần, 3 lần/ngày (cùng với miếng ăn đầu tiên của mỗi bữa chính hoặc uống nguyên viên thuốc với một ít nước ngay trước khi ăn). Để giảm tối thiểu các tác dụng không mong muốn ở đường tiêu hóa, có thể bắt đầu uống 25 mg, 1 lần mỗi ngày, sau đó tăng dần liều để đạt được 25 mg, 3 lần mỗi ngày.

Liều duy trì

Khi đã đạt được liều 25 mg/lần, 3 lần/ngày, cứ cách 4 đến 8 tuần lại điều chỉnh liều dựa theo nồng độ glucose huyết 1 giờ sau bữa ăn hoặc hemoglobin glycosylate và khả năng dung nạp thuốc. Liều lượng có thể tăng từ 25 mg/lần, 3 lần/ngày cho tới 50 mg/lần, 3 lần/ngày. Một số bệnh nhân có thể tăng liều lên đến 100 mg/lần, 3 lần/ngày. Liều duy trì thường dao động từ 50 – 100 mg, 3 lần/ngày. Tuy nhiên, những bệnh nhân có cân nặng thấp có nguy cơ tăng transaminase huyết thanh, do đó chỉ những bệnh nhân trên 60 kg mới nên dùng liều cao trên 50 mg/lần, 3 lần/ngày. Nếu tăng liều đến 100 mg/lần, 3 lần/ngày vẫn không giảm glucose sau ăn hoặc nồng độ hemoglobin glycosylate thì nên giảm liều. Phải duy trì liều có hiệu quả và liều dung nạp được.

Liều tối đa

Nếu bệnh nhân có cân nặng ít hơn hoặc bằng 60 kg: 50 mg/lần, 3 lần/ngày.

Nếu bệnh nhân có cân nặng trên 60 kg: 100 mg/lần, 3 lần/ngày.

Bệnh nhân đang dùng sulfonylurea hoặc insulin
Sulfonylurea hoặc insulin có thể gây tụt đường huyết. Acarbose kết hợp với sulfonylurea hoặc insulin càng làm đường huyết xuống thấp và tăng nguy cơ tụt đường huyết. Nếu xảy ra tình trạng tụt đường huyết, cần chỉnh liều các thuốc này.

Ghi chú: Với liều dùng 25 mg và 50 mg dùng chế phẩm SAVI ACARBOSE 25 và/hoặc SAVI ACARBOSE 50

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với acarbose hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Những bệnh nhân đái tháo đường nhiễm toan thể ceton hoặc xơ gan.
- Người viêm ruột, loét đại tràng, tắc ruột hoặc có nguy cơ tắc ruột.
- Người bị bệnh đường ruột mạn tính do rối loạn tiêu hóa, rối loạn hấp thu hoặc những bệnh nhân bị bệnh lý sinh hơi trong đường ruột.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Chung

Biến chứng mạch máu lớn

Chưa có nghiên cứu lâm sàng cho thấy acarbose hoặc bất kỳ loại thuốc trị đái tháo đường nào có thể giảm nguy cơ biến chứng mạch máu lớn.

Tụt đường huyết

Khi dùng riêng lẻ acarbose không gây tụt đường huyết trong khi ăn hoặc sau bữa ăn như sulfonylurea hoặc insulin, nhưng nếu kết hợp acarbose với sulfonylurea hoặc insulin có thể làm đường huyết xuống thấp và tăng nguy cơ tụt đường huyết. Tụt đường huyết không xảy ra ở những bệnh nhân dùng metformin đơn thuần, ngay cả khi dùng acarbose kết hợp metformin. Để điều trị tụt đường huyết từ nhẹ đến trung bình nên dùng glucose uống (dextrose) mà không dùng sucrose (đường mía) vì sự hấp thu glucose không bị ức chế bởi acarbose. Sự thủy phân sucrose thành glucose và fructose bị ức chế bởi acarbose, do đó không thể phục hồi nhanh glucose huyết. Trường hợp tụt đường huyết trầm trọng có thể sử dụng truyền glucose tĩnh mạch hoặc tiêm glucagon.

Tăng transaminase huyết thanh

Trong các nghiên cứu dài hạn (thời gian dùng thuốc 12 tháng, 300 mg/lần, 3 lần/ngày) thực hiện ở Hoa Kỳ, transaminase huyết thanh (AST và/hoặc ALT) trên mức ULN, gấp 1,8 lần ULN và gấp 3 lần ULN lần lượt là 14%, 6% và 3% đối với bệnh nhân được điều trị bằng acarbose so với 7%, 2% và 1% những bệnh nhân điều trị bằng giả được (ULN: *The Upper Limit of Normal: Giới hạn trên của mức bình thường*). Tuy nhiên sự gia tăng này không có triệu chứng, có thể phục hồi, thường gặp ở nữ giới và không làm rối loạn chức năng gan. Ngoài ra, sự tăng transaminase huyết thanh có thể liên quan đến liều dùng. Trong các nghiên cứu ở Hoa Kỳ, bệnh nhân sử dụng acarbose lên đến liều tối đa được chấp thuận là 100 mg, 3 lần/ngày, mức độ tăng AST và/hoặc ALT tương tự so với những người dùng giả được.

Không kiểm soát được đường huyết

Khi bệnh nhân đái tháo đường bị stress (như sốt cao, chấn thương, nhiễm trùng hoặc phẫu thuật), có thể mất khả năng kiểm soát đường huyết trong thời gian ngắn. Khi đó tạm thời sử dụng insulin.

Xét nghiệm

Khi sử dụng acarbose nên theo dõi nồng độ glucose huyết định kỳ. Đo nồng độ hemoglobin glycosylate để kiểm soát đường huyết dài hạn.

Acarbose, đặc biệt ở liều cao hơn 50 mg/lần, 3 lần/ngày, có thể làm tăng nồng độ transaminase huyết thanh, hiếm khi tăng bilirubin máu. Nên kiểm tra nồng độ transaminase huyết thanh 3 tháng 1 lần trong năm đầu điều trị, sau đó theo dõi định kỳ. Nếu enzyme transaminase tăng, cần giảm liều hoặc ngưng thuốc, đặc biệt nếu mức tăng không thuyên giảm.

Việc kiểm soát đường huyết bằng xét nghiệm 1,5-AG (*1,5-Anhydroglucitol*) không chính xác ở bệnh nhân đang dùng acarbose. Nên sử dụng các phương pháp thay thế để theo dõi đường huyết.

Suy thận

Nồng độ acarbose trong huyết tương ở những người tình nguyện suy thận tăng tương ứng với mức độ rối loạn chức năng thận. Chưa thực hiện các thử nghiệm lâm sàng dài hạn ở bệnh nhân đái tháo đường có rối loạn chức năng thận nặng (creatinine > 2,0 mg/dl). Do đó, không nên dùng acarbose ở những bệnh nhân này.

Gây ung thư, đột biến, giảm khả năng sinh sản

Thực hiện 8 nghiên cứu gây ung thư ở chuột bằng acarbose: 6 nghiên cứu ở hai chủng Sprague-Dawley và Wistar, 2 nghiên cứu ở chuột đồng (Hamsters).

Trong nghiên cứu đầu tiên, cho chuột Sprague-Dawley dùng acarbose liều cao (500 mg/kg trọng lượng cơ thể) trộn chung với thức ăn trong 104 tuần. Việc sử dụng acarbose này làm gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc các khối u thận (u tuyến và ung thư biểu mô tuyến) và các khối u tế bào Leydig lành tính. Nghiên cứu này khi lặp lại cho kết quả tương tự. Nghiên cứu sâu hơn đã được thực hiện để tách biệt tác động trực tiếp gây ung thư của acarbose với các tác động gián tiếp từ suy dinh dưỡng carbohydrate gây ra do liều lượng lớn acarbose tác động trong các nghiên cứu. Trong một nghiên cứu trên chuột Sprague-Dawley bằng cách sử dụng acarbose trộn lẫn với thức ăn đã loại carbohydrate và cho thêm glucose vào chế độ ăn uống. Ở một nghiên cứu trong 26 tháng trên chuột Sprague-Dawley, acarbose được sử dụng bằng cách đưa thuốc vào dạ dày ngay sau bữa ăn hàng ngày để tránh các tác dụng dược lý của thuốc. Acarbose cũng được thực hiện tương tự như trên ở chuột Wistar trong hai nghiên cứu riêng biệt và kết quả cho thấy không có sự tăng tỷ lệ mắc các khối u thận như đã được tìm thấy ở một trong các thí nghiệm đầu trên chuột Wistar.

Trong hai nghiên cứu trên thức ăn của chuột đồng, có và không bổ sung glucose, cũng không có bằng chứng gây ung thư.

Nghiên cứu *in vitro* cho thấy acarbose không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho DNA trong thí nghiệm bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể dùng tế bào non chuột túi má Trung Quốc (*CHO*), thí nghiệm đột biến vi khuẩn (*Ames*), hoặc thí nghiệm liên kết DNA. Trong thí nghiệm *in vivo*, không có tổn thương DNA nào được phát hiện trong thử nghiệm gây chết chiếm ưu thế (*The dominant lethal test*) ở chuột nhắt đực hoặc thí nghiệm trên tế bào vi nhân (*Micronucleus test*) ở chuột nhắt.

Nghiên cứu khả năng sinh sản được tiến hành ở chuột cống sau khi uống acarbose, nhận thấy thuốc không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc sức sinh đẻ.

Trẻ em

An toàn và hiệu quả của acarbose ở trẻ em chưa được xác định.

Người cao tuổi

Trong số các đối tượng nghiên cứu lâm sàng với acarbose ở Hoa Kỳ, 27% bệnh nhân 65 tuổi trở lên, 4% bệnh nhân trên 75 tuổi:

Không có sự khác biệt về an toàn và hiệu quả giữa các đối tượng này so với người trẻ tuổi. Diện tích dưới đường cong trung bình (*AUC*: *Area Under the Curve*) và nồng độ tối đa (*C_{max}*) acarbose ở người cao tuổi gấp 1,5 lần so với người tình nguyện trẻ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Tác dụng gây quái thai: Phân loại B.

Không nên dùng acarbose trong thời kỳ mang thai vì chưa có thông tin đầy đủ từ các nghiên cứu lâm sàng về việc sử dụng ở phụ nữ mang thai, chỉ sử dụng trong khi mang thai nếu thật sự cần thiết. Mức đường huyết bất thường ở phụ nữ mang thai có liên quan đến các dị tật bẩm sinh, bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh. Nên dùng insulin trong thời kỳ mang thai để duy trì đường huyết càng gần mức bình thường càng tốt.

Phụ nữ cho con bú

Một lượng nhỏ thuốc đã được tìm thấy trong sữa chuột cho con bú sau khi cho dùng acarbose được đánh dấu phóng xạ. Chưa biết liệu thuốc có được được bài tiết trong sữa mẹ hay không, không nên dùng acarbose cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

Một số thuốc có xu hướng gây tăng đường huyết và dẫn đến mất kiểm soát glucose trong máu. Các thuốc này bao gồm thiazide và một số thuốc lợi tiểu, corticosteroid, phenothiazine, thyroid, estrogen, thuốc ngừa thai đường uống, phenytoin, acid nicotinic, các thuốc kích thích thần kinh giao cảm, thuốc chẹn kênh calci, isoniazid. Những thuốc này nếu được sử dụng cho bệnh nhân dùng acarbose, nên theo dõi chặt chẽ việc hạ glucose máu. Khi ngưng sử dụng những thuốc này nên theo dõi các dấu hiệu tụt đường huyết ở bệnh nhân

Đối với bệnh nhân đang dùng sulfonylurea hoặc insulin: Do các thuốc này có thể gây tụt đường huyết nên khi kết hợp acarbose với sulfonylurea hoặc insulin càng làm hạ thấp đường huyết và làm tăng khả năng tụt đường huyết. Nếu xảy ra tụt đường huyết, nên điều chỉnh lại liều lượng của các thuốc này. Rất hiếm khi xảy ra tụt đường huyết đột ngột ở những bệnh nhân dùng acarbose kết hợp với sulfonylurea và/hoặc insulin.

Các chất hấp phụ đường ruột (ví dụ than hoạt) và các chế phẩm enzyme tiêu hóa đã tách carbohydrate (ví dụ amylase, pancreatin) có thể làm giảm tác dụng của acarbose, do đó không nên dùng chung.

Acarbose có thể làm thay đổi sinh khả dụng của digoxin khi dùng đồng thời, do đó cần điều chỉnh liều digoxin.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)

Các tác dụng không mong muốn sau có thể xảy ra trong 2 - 3 ngày đầu dùng thuốc: Đầy hơi, sôi bụng, cảm giác đầy bụng hoặc đau bụng.

Thông báo ngay với bác sĩ nếu sau hơn 2 - 3 ngày các triệu chứng trên vẫn tiếp tục hoặc xảy ra nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu bị tiêu chảy.

Tóm tắt các ADR

Rất thường gặp: *ADR* ≥ 1/10

Tiêu hóa: Đầy hơi

Thường gặp: *1/100* ≤ *ADR* < *1/10*

Tiêu hóa: Tiêu chảy, đau dạ dày, đau bụng.

Ít gặp: *1/1.000* ≤ *ADR* < *1/100*

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, khó tiêu.

Gan mật: Tăng enzyme gan.

Hiếm gặp: *1/10.000* ≤ *ADR* < *1/1.000*

Mạch máu: Phù.

Gan mật: Vàng da.

Chưa rõ tần suất

Máu và hệ bạch huyết: Giảm tiểu cầu.

Hệ miễn dịch: Dị ứng thuốc, phản ứng quá mẫn (phát ban, ban đỏ, xuất huyết, mày đay).

Tiêu hóa: Tắc ruột, trướng khí ở đại tràng(*).

Gan mật: Viêm gan.

Da và mô dưới da: Hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính.

(*) *Trướng khí ở đại tràng*

Các triệu chứng có thể gặp: Tiêu chảy, tiết dịch nhầy, chảy máu trực tràng, táo bón.

Biến chứng của tình trạng trướng khí đại tràng gồm: Tráng khí phúc mạc, xoắn ruột, tắc ruột, lồng ruột, xuất huyết ruột, thủng ruột. Nếu nghi ngờ bị trướng khí, ngừng dùng thuốc và tiến hành các chẩn đoán thích hợp bằng hình ảnh.

Một số tác dụng không mong muốn khác

- Các trường hợp rối loạn gan, chức năng gan bất thường và tổn thương gan đã được báo cáo. Đã có trường hợp viêm gan cấp tính dẫn đến tử vong.

- Những bệnh nhân dùng liều hàng ngày từ 150 đến 300 mg acarbose, hiếm khi có kết quả xét nghiệm chức năng gan bất thường có liên quan lâm sàng (cao gấp ba lần giới hạn trên của mức bình thường). Các giá trị bất thường có thể chỉ tạm thời trong khi sử dụng acarbose.

- Nồng độ calci huyết và vitamin B6 trong máu thấp.

- Nếu bệnh nhân không tuân thủ chế độ ăn uống theo hướng dẫn có thể làm tăng các tác dụng không mong muốn trên đường ruột. Nếu các triệu chứng trên ngày càng nặng dù đã tuân thủ chế độ ăn uống quy định dành cho người đái tháo đường, cần thông báo ngay cho bác sĩ, có thể phải giảm liều tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Tác dụng không mong muốn về tiêu hóa có thể giảm khi vẫn tiếp tục điều trị và chỉ cần giảm lượng đường ăn (đường mía).

Để giảm thiểu các tác dụng không mong muốn về tiêu hóa, nên bắt đầu điều trị bằng liều thấp nhất và tăng dần cho tới khi đạt được kết quả mong muốn.

Không dùng thuốc kháng acid để điều trị các tác dụng không mong muốn về tiêu hóa này.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Biểu hiện

Không giống như sulfonylurea hoặc insulin, quá liều acarbose không gây tụt đường huyết nhưng có thể gây đầy hơi, tiêu chảy, khó chịu ở bụng và sẽ giảm dần sau đó.

Cách xử trí

Trong trường hợp dùng quá liều, người bệnh không nên uống rượu hoặc dùng các thức ăn có chứa nhiều carbohydrate (polysaccharide, oligosaccharide và disaccharide) trong 4 đến 6 giờ.

DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm được lý: Thuốc hạ glucose máu – chống đái tháo đường (ức chế alpha-glucosidase)

Mã ATC: A10BF01

Cơ chế tác dụng

Khác với sulfonylurea, acarbose không làm tăng tiết insulin. Tác dụng hạ đường huyết của acarbose do ức chế enzyme alpha-amylase ở tụy và enzyme alpha-glucosidase ở ruột. Alpha-amylase tụy sẽ thủy phân các phức hợp tinh bột thành oligosaccharide tại ruột non, trong khi enzyme alpha-glucosidase tại thành ruột sẽ thủy phân các oligosaccharide, trisaccharide, disaccharide thành glucose và các monosaccharide ở bờ bàn chải của ruột non. Ở bệnh nhân đái tháo đường, ức chế enzyme này làm cho hấp thu glucose chậm và giúp hạ đường huyết sau ăn.

Do cơ chế hoạt động của acarbose, sulfonylurea, insulin, metformin khác nhau trong việc kiểm soát gia tăng đường huyết, nên chúng có tác dụng cộng hợp khi dùng chung. Ngoài ra, acarbose còn làm giảm tác dụng kích thích tiết insulin và tăng cân của sulfonylurea.

Acarbose không ức chế enzyme lactase, do đó sẽ không gây mất dung nạp lactose.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu

Sau khi uống, phần lớn acarbose lưu lại trong ống tiêu hóa để được các enzyme tiêu hóa và vi khuẩn chí ở ruột chuyển hóa để acarbose phát huy tác dụng được lý. Dưới 2% liều uống được hấp thu dưới dạng thuốc có hoạt tính, trong khi đó, khoảng 35% liều uống được hấp thu chậm dưới dạng chất chuyển hóa được tạo thành trong đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh của acarbose trong huyết tương khoảng 1 giờ. Nồng độ đỉnh của các chất chuyển hóa trong huyết tương từ 14 - 24 giờ sau khi uống.

Chuyển hóa

Acarbose được chuyển hóa hoàn toàn ở đường tiêu hóa, chủ yếu do vi khuẩn chí đường ruột và một lượng ít hơn do enzyme tiêu hóa. Ít nhất 13 chất chuyển hóa đã được xác định.

Thải trừ

Thời gian bán thải của acarbose hoạt tính trong huyết tương khoảng 2 giờ, như vậy không có hiện tượng tích lũy thuốc khi uống 3 lần mỗi ngày. Khoảng 51% liều uống được đào thải qua phân dưới dạng acarbose không hấp thu, trong vòng 96 giờ. Khoảng 34% liều uống đào thải qua thận dưới dạng các chất chuyển hóa hấp thu. Dưới 2% liều uống đào thải qua nước tiểu dưới dạng acarbose và chất chuyển hóa hoạt động.

Đối tượng đặc biệt

Diện tích dưới đường cong trung bình (*AUC*: *Area under the curve*) ở trạng thái ổn định và nồng độ acarbose tối đa (*C_{max}*) ở người tình nguyện trẻ tuổi cao hơn khoảng 1,5 lần so với người cao tuổi. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân suy thận nặng (*Cl_{cr}* < 25 ml/phút/1,73m²) đạt nồng độ đỉnh cao gấp 5 lần và *AUC* lớn hơn 6 lần so với những người tình nguyện có chức năng thận bình thường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Sản xuất tại



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI (*Savvipharm J.S.C*)
Lô Z.01-02-03a Khu công nghiệp Trung Yên Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 37700142-143-144 - Fax: (84.28) 37700145

